

INDICADO POR: Amigo Rodolfo

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS E5424A08018

JEFERSON FREIRE DOS SANTOS

JMC-2841

IDADE: 46 PESO: 88 ALTURA: 1.76 PROFISSÃO:

SINTOMAS:

Trabalha 8:50 - 2:30m - acorda 8hrs.

QUEIXAS: Sonolência / Rouco alto em 10 piores.

MEDICAMENTOS: não

MÉDICO: Dr. Bruno

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Não faz

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 8 ALMOÇO: 13-14 LANCHE: 17 JANTAR: 20.

HORA QUE DORME: 2:30 HORA QUE ACORDA: 8m

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE Rouco leve

TEM FILHOS: ☒ S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N alguns

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: -

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 18,4 SPO2: 87%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não

- Pos Covid (relata estar c/ dif. p/ engasgar/esquecido)

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Devio septo

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 CI CPAP: - PRESSÃO NO EXAME: -

25/06 Avaliação (4-10cmH2O)

-25 D Pillow (m)

03/07/25 P=5,3cmH2O Auto 4 a 6cmH2O
m. de uso =

usage = 6,5 e pu
IAH = 1,4 e 1h Jca atrecho

25/07/25 P=4,2cmH2O Peruntil: 5,0cmH2O

IAH = 0,7 e 1h m. uso = 5h08min Jante bem.

for fupg = 5l/min silva.

Nome: JEFFERSON FREIRE DOS SANTOS

Data de Nascimento: 24-5-1979

IMC: 28,41

Sexo: Masculino

Data do exame: 13-07-2024

Peso: 88 kg

Altura: 1,76 m

Médico: DR. ENIO NARUHIRO KOKUBU

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 13-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 497,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 24,0 e 55,0 minutos. O tempo total de sono foi de 457,0 min, eficiência de 91,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 61,5%; estágio N3: 11,7%; sono REM: 24,8%. O índice de despertares foi de 14,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,4/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 135 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 87%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 86 bpm e NREM de 52 - 90 bpm.

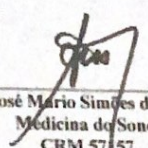
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 18,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=87%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157